Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Seção A da 33ª Vara Cível da Capital

Avenida Desembargador Guerra Barreto - Fórum do Recife, S/N, Ilha Joana Bezerra, RECIFE - PE - CEP: 50080-900 - F: (81) 31810494

Processo nº 0002440-09.2024.8.17.4001

AUTOR(A): L. L. F.

RÉU: BRADESCO SAÚDE S/A

SENTENÇA

Vistos, etc...

L.L.F., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora RAFAELLA V LOURENÇO, ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais em face de BRADESCO SAÚDE S/A.

Consta na inicial que o autor é beneficiário do plano de saúde individual ofertado pela Ré, na categoria Multi TOP - Quarto, Rede Nacional, estando em dia com as mensalidades, conforme comprovantes em anexo.

Argumenta ainda ter sido diagnosticado com Baixa Estatura Idiopática a (CID 10: E34.3), razão pela qual o médico assistente prescreveu tratamento com hormônio do crescimento (Somatropina), na dose de 2,1mg todas as noites podendo tal reposição ocorrer com: a) Norditropin ou Omnitrope 15mg (5amp/mês), OU b) Norditropin ou Omnitrope 10mg (7amp/mês) OU c) Saizen 20mg (4amp/mês), OU Criscy 10mg (7amp/mês).

Alega a parte autora que tentou obter a medicação administrativamente, conforme protocolos gerados de nº 00571120230808019566, 00571120230808019894 e 00571120230811000580 6, o que foi negado pela operadora de saúde, ID. 17438321.

Oportunizado o contraditório, o Bradesco Saúde alegou inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, à medida que justifica a negativa no rol de procedimentos da ANS.

Indeferida a antecipação da tutela por Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013. ID. 181100560.

Contestação no ID. 181612266, que impugna, entre outros pontos, o valor da causa.

Relatados, no que importa, decido.

Trata-se de Procedimento Comum em que o demandante pleiteia provimento jurisdicional que determine à parte ré a obrigação de fornecer o medicamento prescrito pelo(a) médico(a) assistente, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de injustificada recusa, o que caracteriza má prestação do serviço.

O feito comporta julgamento antecipado, por se tratar de matéria exclusivamente de direito, além do que está suficientemente instruído com prova documental.

Inicialmente, quanto a impugnação ao valor da causa, verifico que foi contestado de forma meramente genérica, ocasião em que o réu, inclusive, se refere ao procedimento da lei 9.099/95, nos exatos termos da contestação: *"correspondem a PEDIDO ILÍQUIDO, pedido estes que não cabem em sede de Juizado Especial Cível. Conforme determinação do artigo 38 da Lei 9.099 95"*

Observo ainda que o requerimento da autora foi o fornecimento da medicação na rede credenciada da operadora de saúde, sendo o valor desse custo desconhecido pela parte autora e que a ré, em sede de contestação, deixou de informar.

Também, não há que se falar em chamamento do Estado ao processo, eis que em se tratando de relação de consumo não há lugar para a denunciação da lide. A relação do autor para com o réu é absolutamente distinta da obrigatoriedade do poder público prestar a assistência médica e universal pelo SUS, aos que dele necessitem.

Destaco o que consta do laudo médico que instrui a inicial: *"o tratamento do menor se baseia em aplicações diárias do hormônio, com a dosagem atual de 2,1mg e acompanhamento trimestral com médico especialista em endocrinologia pediátrica. [...] o tratamento deve ser diário e contínuo, e a descontinuidade prejudica a resposta clínica, comprometendo altura final do paciente. Ressalto que este tratamento tem de ser realizado o mais urgente possível pois a falta do tratamento leva a danos irreversíveis na altura final. Até o momento a literatura médica não contempla outra opção terapêutica para esta enfermidade."*

Não há dúvida quanto à existência da contratação e a negativa de cobertura, bem como ser adequada a medicação prescrita para tratar o quadro do autor.

Por outro lado, é importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento pela não obrigatoriedade das operadoras de saúde fornecerem medicação para uso domiciliar, exceto os neoplásicos haja vista expressa exclusão prevista no art. 10, VI, da lei nº 9656/98, consoante a seguir se vê:

> "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).

No mesmo sentido, envolvendo a mesma medicação do caso sub judice, as seguintes decisões monocráticas: REsp 2143661 (https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/stj/2506712258), Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Data da Publicação 21/05/2024; REsp 2059238, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data da Publicação 16/08/2024.

Impende transcrever a Ementa do Acórdão recente do Tribunal de Justiça de Pernambuco:

> "AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) nº 0002278-86.2023.8.17.9000 AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: MELINA MARIA SALVINO DA SILVA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. HORMÔNIO DO CRESCIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. REVOGADA A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO

PRIMEIRO GRAU. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. **O art. 10, VI, da Lei 9.656/98 exclui da cobertura assistencial mínima prestada pelas operadoras de planos de saúde o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar.** Entendimento seguido pela ANS na Resolução Normativa nº 465/2021 e pelo Parecer Técnico nº 21/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021. Prejudicada a probabilidade do direito alegado. **2. Ausência de risco iminente à vida ou à saúde da paciente, afastando a urgência no provimento jurisdicional.** 3. Recurso provido. Decisão unânime. Relator: Juiz Silvio Romero Beltrão"

Nesse contexto, havendo **expressa previsão legal** que limita a obrigação da operadora de saúde no que diz respeito a fornecer medicação para uso domiciliar, consoante ressaltado no Acórdão supra, entende-se que a negativa encontra respaldo legal e está alinhada com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

É de se ressaltar que subsiste a obrigatoriedade do poder público prestar a necessária assistência à saúde da autora, conforme prescrevem as normas que regem o sistema único de saúde, o que, efetivamente, é incontroverso nos Tribunais pátrios.

As relações contratuais são regidas pelos princípios da boa-fé e força obrigatória, de modo que a intervenção judicial se restringe a impedir práticas ilegais e abusivas, o que não é o caso, sobretudo porque a recusa da operadora está amparada em texto expresso de lei, cuja interpretação somente pode ser relativizada nos casos em que houver risco de vida do paciente.

Ressalto posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Agravo Interno em ED para hipótese semelhante, com a posição de ambas as suas Turmas ao caso:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. INSUMOS PARA BOMBA INFUSORA DE INSULINA. **TRATAMENO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA.** JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE DIREITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI 14.454/2022. ALEGAÇÃO DE ROL EXEMPLIFICATIVO. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. 1. Controvérsia pertinente à obrigatoriedade de cobertura de bomba infusora de insulina (e insumos) para controle de glicemia de paciente diagnosticado com diabetes mellitus tipo 1 em ambiente domiciliar. **2. Ausência de obrigatoriedade de cobertura de tratamento domiciliar, salvo nas hipóteses de 'home care' ou de terapia antineoplásica. Exegese do art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998, consoante julgados recentes desta Corte Superior.** 3. Julgado específico desta TURMA acerca da ausência de obrigatoriedade de cobertura de bomba de insulina, **por se tratar de equipamento de uso domiciliar**. 4. Ausência de alteração da força normativa do já citado art. 10, inciso VI, da Lei 9.656/1998 ante a superveniência da Lei 14.454/2022, de modo que a tese do rol exemplificativo não infirma a conclusão pela ausência de obrigatoriedade de cobertura da bomba de insulina. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1987778 SC 2022/0055671-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)" (grifos para destacar).

Mais:

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. **PLANO DE SAÚDE. BOMBA INFUSORA DE INSULINA. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DO PLANO DE REFERÊNCIA. ART. 10, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. INOBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. JULGADOS DE AMBAS AS TURMAS DE**

DIRITO PRIVADO DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO ESPECIAL PROVIDO." ((STJ - REsp: 2026198, Relator: PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: 06/03/2023)" (grifos para destacar)

"AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INSULINA. **MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR, ADQUIRIDO EM FARMÁCIA COMUM. NÃO ENQUADRAMENTO COMO ANTINEOPLÁSICO, COMO MEDICAÇÃO ASSISTIDA (HOME CARE) NEM ESTÁ ENTRE OS INCLUÍDOS NO ROL DA ANS PARA ESSE FIM. COBERTURA LEGAL OBRIGATÓRIA. INEXISTÊNCIA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÂMBITO DO STJ.** PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO.

1. Como bem ponderado pela Corte local, "a bomba infusora de insulina é aparelho que pode ser facilmente adquirido em farmácias", sendo, pois, tecnicamente medicamento de uso domiciliar. Com efeito, como assentado pela Terceira Turma, é "lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp n. 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021).

2. "Domiciliar, de acordo com a lei, refere-se a ambiente que, necessariamente, contrapõe-se a ambulatorial e a hospitalar, com o que se exclui da cobertura legal o fornecimento de medicamentos que, mesmo prescritos pelos profissionais da saúde e ministrados sob sua recomendação e responsabilidade, devam ser utilizados fora de ambulatório ou hospital" (REsp 1883654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 02/08/2021).

3. Por um lado, como ponderado em recente recurso repetitivo julgado pela Segunda Seção, REsp n. 1.755.866/SP, relator Ministro Marco Buzzi, a universalização da cobertura não pode ser imposta de modo completo e sem limites ao setor privado, porquanto, nos termos dos arts. 199 da Constituição Federal e 4º da Lei n. 8.080/1990, a assistência à saúde de iniciativa privada é exercida em caráter complementar, sendo certo que a previsão dos riscos cobertos, assim como a exclusão de outros, é inerente aos contratos. Por outro lado, a saúde suplementar cumpre propósitos traçados em regras legais e infralegais. Assim sendo, não se limita ao tratamento de enfermidades, mas também atua na relevante prevenção, não estando o Judiciário legitimado e aparelhado para interferir, em violação da tripartição de Poderes, nas políticas públicas. Precedente.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.973.853/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)" (grifos para destacar)

Incorporo ainda a estas razões de decidir os seguintes julgados, oriundos do TJPE:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DOMICILIAR. **HORMÔNIO DO CRESCIMENTO**. INEXISTÊNCIA DE RISCO À VIDA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. 1. Nos casos de urgência e emergência, em que o risco à vida se revele presente, admite-se interpretação extensiva do art. 10, VI, da lei 9.656/98 – que exclui da cobertura assistencial mínima o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar - para abranger o medicamento ministrado

por orientação do médico assistente fora do regime de internação hospitalar, levando-se em conta a natureza do contrato de plano de saúde e a sua finalidade precípua de proteção à vida e à saúde do contratante. 2. Hipótese em que o tratamento medicamentoso pleiteado não se apresenta como terapia fundamental para a vida do paciente, mormente porque o laudo do médico assistente justifica a urgência do início do tratamento com o hormônio do crescimento tão somente no fato de a menor ficar com "altura final muito abaixo do padrão populacional feminino e genético". 3. Apelação a que se dá provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível 0000272-59.2020.8.17.2001, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - AC: 00002725920208172001, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 31/08/2022, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC)).

"PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AFASTAR JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA E PRELIMINAR DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS REJEITADA. MEDICAMENTO INVEGA SUSTENA. ESQUIZOFRENIA CRONICA. NEGATIVA. DOMICILIAR (NENHUMA HIPOTESE DO ARTIGO art. 10,VI, e 12 da Lei nº 9.656/1998. **FÁRMACO QUE NÃO SE RELACIONA A TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO, NEM DE USO HOSPITALAR OU AMBULATORIAL.** EXCLUSÃO ANS. ROL TAXATIVO. RECUSO DA RÉ PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em regra, o plano de saúde não é obrigado a fornecer medicamentos de uso domiciliar, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e outros fármacos incluídos pela ANS no rol de fornecimento obrigatório. Precedentes STJ. 2. In casu, EMBORA comprovada a necessidade de a paciente utilizar o medicamento solicitado como única terapia disponível, o Plano de Saúde não possui o dever de custear o medicamento de uso domiciliar (Invega Sustenna), pois extrapolaria os limites contratuais e legais, 3. Dado o provimento do recurso, inverte-se a sucumbência e fixa-se honorários advocatícios em R$ 500,00. 4. Recurso provido. (TJ-PE - AC: 00702011920198172001, Relator: SILVIO ROMERO BELTRAO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))" (grifos para destacar)".

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. FORNECIMENTO DE MONITOR E SENSOR CONTÍNUO DE GLICEMIA (FREESTYLE LIBRE). NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DOS ÍNDICES GLICÊMICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DEVER DE CUSTEIO PELA SEGURADORA. TRATAMENTO DOMICILIAR. IMPROVIMENTO DO RECURSO. - O cerne da demanda consiste em averiguar o dever da Agravada em custear o tratamento perseguido nos autos - monitor e sensor contínuo de glicemia (FREESTYLE LIBRE). - Conforme estabelecido na Lei nº 9.656/98 e precedentes do c. STJ, é lícita a exclusão do fornecimento de medicamentos e insumos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásicos orais e correlacionados (arts. 10, VI e 12, I, c e II, g, da Lei 9.656/98). - Portanto, encontram-se excluídos da cobertura pelos planos de saúde aquelas medicações/insumos adquiridos facilmente em farmácias e cuja aplicação (uso) pode se dar no âmbito domiciliar (Precedentes c. STJ). - Do

mesmo modo, diante da desnecessidade de intervenção médico-cirúrgicas relacionadas ao fornecimento do aparelho, encontram-se excluídos da cobertura obrigatória pelas operadoras, nos termos do art. 10, VII, da Lei de regência. - Recurso desprovido. (TJ-PE - AI: 00166532920228179000, Relator: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 20/03/2023, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes)" (grifos para destacar)"

Nesse contexto, considerando que a recusa foi amparada em expressa disposição legal, não há prática de ato ilícito que dê ensejo ao dever de indenizar, razão pela qual o pedido inicial não há como ser acolhido.

Em que pese o art. 14 do CDC prever a responsabilidade objetiva dos prestadores de serviço frente ao consumidor, tal somente subsiste quando demonstrada a prática de ato ilícito, o que não ocorreu.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, **JULGO IMPROCEDENTES** pedidos formulados na inicial, o que faço com fundamento nos dispositivos legais acima mencionados e declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC .

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais (já satisfeitas) e honorários advocatícios, estes últimos estipulados no patamar mínimo de 10% sobre o valor da causa, haja vista tratar-se de questão de baixa complexidade.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para contrarrazões e encaminhem-se os autos ao E. TJPE, observadas as formalidades legais, independentemente de novo despacho.

Recife-PE, 1 de outubro de 2024.

ANA CAROLINA AVELLAR DINIZ

Juíza de Direito

mcvs

Assinado eletronicamente por: ANA CAROLINA AVELLAR DINIZ
02/10/2024 10:26:06
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 183916072

24100210260579200000179403660

IMPRIMIR GERAR PDF